Keizersnede (sectio caesarea)

U wordt opgenomen in het HagaZiekenhuis Zoetermeer voor een keizersnede. Een keizersnede (sectio caesarea) is een operatie waarbij de baby door een opening (snede) in de onderbuik ter wereld komt. Een keizersnede kan van tevoren worden ingepland of tijdens de bevalling noodzakelijk zijn (spoed keizersnede). In het HagaZiekenhuis Zoetermeer bieden wij ook de natuurlijke sectio aan. Hierbij kunt u als u dit wenst uw baby geboren zien worden via een doorzichtig scherm. Als het mogelijk is blijft uw baby warm toegedekt bij u liggen op de operatiekamer, totdat u samen terug kunt naar de afdeling. Bij een spoedkeizersnede is dit vaak niet mogelijk.

Zorgpaden

Het HagaZiekenhuis Zoetermeer werkt voor een deel van haar patiëntengroepen met zorgpaden. Een zorgpad beschrijft op een heldere manier de stappen die u als patiënt doorloopt zodat duidelijk is waar u op welk moment aan toe bent binnen uw zorgtraject.

Hieronder ziet u schematisch weergegeven welke stappen u de komende tijd zult doorlopen. Deze stappen worden verderop toegelicht.

Toestemming

U bespreekt met de gynaecoloog de keizersnede. U verleent dan ook toestemming tot de behandeling. Uw specialist kan u expliciet om toestemming vragen.

Schematische weergave zorgpad

1. Preoperatief	2. Operatiedag	3. De dag van het ontslag	4. Nazorg
• Polibezoek gynaecoloog • Preoperatief spreekuur anesthesist	• Opname • Opnamegesprek • Operatie	• Controle gynaecoloog / klinisch verloskundige • Controle kinderarts • Ontslag	• Polibezoek gynaecoloog

Stap 1: Preoperatief

Polibezoek gynaecoloog

De gynaecoloog heeft samen met u besloten dat uw baby geboren wordt via een keizersnede.

Redenen voor een vooraf geplande keizersnede kunnen zijn:

- Vernauwd bekken
- Eerdere keizersnede
- Placenta die voor de baarmoedermond ligt
- Bepaalde ziektes van de moeder
- Afwijkende ligging van de baby

Het kan voorkomen dat uw vliezen breken of de bevalling begint voor de geplande keizersnede. Graag dan contact opnemen met de afdeling verloskunde. Mogelijk wordt de keizersnede eerder uitgevoerd.

Planningsbureau

- Bij een vooraf geplande keizersnede neemt het planningsbureau telefonisch contact met u op.
- Het planningsbureau stelt de datum van uw keizersnede vast.
- Ter voorbereiding van de keizersnede krijgt u een afspraak op het anesthesiespreekuur, een afspraak met een medewerker van de ziekenhuisapotheek. Telefonisch of in het ziekenhuis zelf.
- U krijgt digitaal een preoperatieve vragenlijst en een toestemmingsformulier apotheek.

Anesthesiespreekuur

- De anesthesioloog bekijkt of u een telefonische of een afspraak op de polikliniek krijgt.
- Het bezoek aan de polikliniek anesthesie duurt ongeveer 45 minuten.
- Wanneer dit consult telefonisch kan, wordt u gebeld door de anesthesioloog.

Nuchter melden

Voor de operatie dient u nuchter te zijn. Dit houdt in:

- Vanaf 6 uur voor de opname niets meer eten en geen kauwgom gebruiken.
- Drinken van heldere (= doorzichtige !) drank is toegestaan tot 2 uur voor de opname, daarna niets meer eten of drinken.
  N.B. melkproducten, dranken met vruchtvlees, suiker, alcohol en andere toevoegingen in de drank zijn **niet** toegestaan.

Voorbereiding

Sieraden, haarspelden, make-up, nagellak, contactlenzen en piercings moeten verwijderd zijn voordat u naar de operatiekamer gaat. Ook uw partner mag geen sieraden dragen op de operatiekamer. Mobiele telefoons mogen alleen gebruikt worden om foto's mee te maken. Het is niet toegestaan om te filmen, bellen of appen in de operatiekamer.

Graag uw waardevolle spullen thuis laten.

Stap 2: Operatiedag

Melden bij de verpleegafdeling

U meldt zich op de afgesproken tijd op de afdeling verloskunde op de eerste etage. Hier wordt u ontvangen door een verpleegkundige van de afdeling.

Voorbereiding

- Indien de reden van de keizersnede een stuitligging is, maakt de gynaecoloog of klinisch verloskundige een echo ter controle van de ligging. Blijkt dat de baby weer in hoofdligging ligt, dan zal de keizersnede niet plaats vinden en wordt in overleg met u een verder beleid bepaald.
- Harttonen luisteren en indien nodig wordt er een CTG gedraaid.
- Een kort opnamegesprek met de verpleegkundige.
- Uw temperatuur, bloeddruk en pols worden gecontroleerd.
- U krijgt een operatie jasje aan.
- In uw hand of arm wordt een infuus ingebracht en meteen bloed afgenomen om het meest recente Hb (ijzergehalte) te kunnen bepalen. Het infuus dient om vocht en medicijnen te geven.
- Uw blaas moet tijdens de operatie leeg blijven. Daarom wordt op de OK een blaaskatheter ingebracht, waardoor u zelf niet hoeft te plassen.

Operatie

- Als u naar de operatiekamer mag brengt de verpleegkundige u samen met uw partner naar de voorbereidingsruimte van de operatiekamers waar het operatieteam de laatste voorbereidingen treft. Vergeet uw fototoestel / telefoon niet mee te nemen.
- Uw partner krijgt net als de gynaecoloog en verpleegkundige operatiekleding aan.
- Op de operatiekamer wordt de ruggenprik geplaatst. Tijdens het plaatsen van de ruggenprik mag uw partner bij u blijven.
- Het operatieteam bestaat uit de gynaecoloog, anesthesist, operatie-assistent, anesthesie-assistent, operatieverpleegkundige. Ook is er een kinderarts(-assistent) aanwezig en de verpleegkundige van de afdeling.
- Tijdens de keizersnede wordt u afgedekt met steriele doeken. Wanneer de baby geboren wordt en u gekozen heeft voor een natuurlijk keizersnede kunt u door een doorschijnend operatiedoek uw baby geboren zien worden. Indien mogelijk wordt uw partner in de gelegenheid gesteld om de navelstreng door te knippen.
- De gynaecoloog legt uw baby in een wiegje en wordt daarmee naar de couveuse gebracht waar de kinderarts (-assistent) uw baby nakijkt,
- Als het medisch verantwoord is wordt uw baby bij u in de Mistral Air gelegd. Dit is een deken waar warme lucht in wordt geblazen om uw kindje goed warm te houden.
- Wanneer dit verantwoord is en de personele bezetting van de afdeling dit toelaat blijft uw baby bij u liggen tijdens het sluiten van de operatiewond.
- Indien verantwoord gaat u direct als gezin vanaf de operatiekamer terug naar afdeling verloskunde.

Na de operatie

- Wanneer u terug bent op de afdeling controleren wij uw bloeddruk, pols en temperatuur regelmatig.
- Indien u graag borstvoeding wilt geven proberen wij binnen een uur na de geboorte de baby aan te leggen.
- Na de operatie proberen wij de pijn zo goed mogelijk te bestrijden. U wordt gevraagd een cijfer te geven hoe u de pijn ervaart (1-10: van geen tot heel veel pijn). U krijgt pijnstillende medicijnen volgens protocol en wij adviseren u ook om die te nemen om een spiegel in uw bloed op te bouwen.
- Ook krijgt u medicatie per injectie ter voorkoming van trombose.
- Binnen 6 uur mag u vast voedsel eten en wij adviseren u om kauwgom te kauwen.
- Uw baby wordt verzorgd op de kamer.
- Uw katheter wordt 6-12 uur na de operatie verwijderd en de verpleegkundige helpt u onder de douche. Als dit niet lukt, wordt u op bed verzorgd door de verpleegkundige.
- Wanneer u eraan toe bent mag u bezoek ontvangen. Wij adviseren niet te veel bezoek tegelijk te laten komen en genoeg rustmomenten te nemen.
- Wij streven ernaar dat uw partner de eerste nacht bij u kan blijven.
- Wij adviseren u uw kraamzorg alvast op de hoogte te stellen dat u bevallen bent door middel van een keizersnede. Minimaal 5 uur kraamzorg per dag is noodzakelijk wanneer u naar huis gaat.

Stap 3: De dag van ontslag

De dag van ontslag

- De gynaecoloog of klinisch verloskundige komt vandaag bij u langs.
- Indien het nodig is wordt bloed afgenomen om uw Hb (ijzergehalte) te bepalen.
- U krijgt nogmaals een injectie ter voorkoming van trombose en medicatie om de ontlasting soepel te houden.
- De kinderarts komt uw baby nog een keer nakijken.
- Als alles goed gaat met u en uw baby mag u met ontslag. (Bij het vervoeren van kinderen in de auto is een baby autostoeltje verplicht.)
- Zorg ervoor dat u thuis alles heeft voorbereid voor uw herstel na de keizersnede.
- U krijgt ontslagpapieren mee.
- Wij adviseren u ervoor te zorgen dat u bij thuiskomst voldoende pijnmedicatie in huis heeft, zoals paracetamol en naproxen.

Problemen thuis

Wanneer u met ontslag bent geeft de verpleegkundige aan uw verloskundige door dat u thuis bent, mochten er vragen of problemen zijn dan kunt u of uw kraamverzorgende contact opnemen met uw verloskundige.

Stap 4: Nazorg

Aangifte

- Binnen 3 dagen na de geboorte dient u aangifte te doen. Daarbij gelden de volgende regels:
- De geboortedag zelf telt niet mee. Dus als uw kind dinsdag geboren is, moet u uiterlijk vrijdag aangifte doen.
- Weekenden en feestdagen tellen ook niet mee. Dus als u kind vrijdag geboren wordt, heeft u tot woensdag de tijd om aangifte te doen.
- Maak voor de geboorteaangifte via internet een afspraak bij het gemeentehuis. In een aantal gevallen kan de aangifte digitaal gedaan worden.

Polibezoek

Ongeveer 5 weken na de keizersnede krijgt u een afspraak bij de gynaecoloog. Dat kan telefonisch of op de polikliniek. Deze afspraak maken wij voor u bij ontslag.

Wat vindt u van deze patiënteninformatie?

Wij horen graag uw mening over deze folder. Wilt u na het lezen enkele vragen beantwoorden? U vindt de vragen via deze link: https://folders.hagaziekenhuis.nl/2228. Dank u wel.

Spreekt u geen of slecht Nederlands?

De informatie in deze folder is belangrijk voor u. Als u moeite heeft met de Nederlandse taal, zorg dan dat u deze folder samen met iemand leest die de informatie voor u vertaalt of uitlegt.

Do you speak Dutch poorly or not at all?

This brochure contains information that is important for you. If you have difficulty understanding Dutch, please read this brochure with someone who can translate or explain the information to you.

Czy Państwa znajomość języka niderlandzkiego jest żadna lub słaba?

Informacje zawarte w tym folderze są ważne dla Państwa. Jeśli język niderlandzki sprawia Państwu trudność, postarajcie się przeczytać informacje zawarte w tym folderze z kimś, kto może Państwu je przetłumaczyć lub objaśnić.

Hollandaca dilini hiç konuşamıyor musunuz veya kötü mü konuşuyorsunuz?

Bu broşürdeki bilgi sizin için önemlidir. Hollandaca dilinde zorlanıyorsanız, bu broşürü, size tercüme edecek ya da açıklayacak biriyle birlikte okuyun.

إذا كنتم لا تتحدثون اللغة الهولندية أو تتحدثونها بشكل سيء إن المعلومات الموجودة في هذا المنشور مهمة بالنسبة لكم. إذا كانت لديكم صعوبة في اللغة الهولندية، فاحرصوا عندئذ على قراءة هذا المنشور مع شخص يترجم المعلومات أو يشرحها لكم.